Traitement antibiotique de la légionellose chez l’adulte Actualisation

Groupe recommandations de la SPILF

2026

Epidémiologie

- *Legionella pneumophila* sérogroupe 1 : 80 à 90% des cas en France
- 5% des PAC
- 1/3 des patients hospitalisés pour légionellose est en réanimation
- Incidence en France en 2024 : 2,8/10^5 habitants (2000 cas/an)
- Létalité en France en 2024 : 9%, jusqu'à 40% chez l'immunodéprimé
- Contamination :
  - Inhalation d'aérosol d'eau contaminée
  - Pas de transmission interhumaine
- Maladie à déclaration obligatoire

Diagnostic microbiologique

- Antigénurie : test diagnostique de référence
  - Ne détecte que le sérogroupe Lp1
  - Détectable 1 à 3 jours après le début des symptômes
  - Persistance possible pendant plusieurs semaines voire mois
  - Sensibilité de **70 à 90 %**

    inférieure à 50 % chez les patients présentant une forme modérée,

    supérieure à 85 % chez ceux présentant une forme grave
  - Spécificité proche de **100 %**

- PCR uniquement sur prélèvements respiratoires profonds
  - Sensibilité de **70 à 90 %**
  - Spécificité proche de **100 %**

- Culture sur milieu spécifique : uniquement recommandée pour comparaison avec une souche environnementale

- La sérologie légionnelle **n'est pas recommandée**

Facteurs de risque d’infection

- Hémopathies malignes et tumeurs solides sous chimiothérapie cytotoxique
- Transplantation d'organe
- Traitements immunosuppresseurs, glucocorticoïdes , anti-TNF-α…
- Maladies pulmonaires chroniques
- Tabagisme
- Diabète
- Sexe masculin
- Age > 65 ans
- Exposition a des systèmes d’aérosolisation de l’eau (hammam, balnéothérapie etc…)

Stratégie thérapeutique d'une légionellose documentée

- **Forme non grave, patient non immunodéprimé**
  - Traitement possible en ambulatoire
  - Macrolide en monothérapie
    - Azithromycine

  Alternatives :
    - Clarithromycine ou Spiramycine (existent sous forme injectable)
    - Roxithromycine

- **Forme grave et/ou patient immunodéprimé**
  - Lévofloxacine en monothérapie

  Alternatives :
    - Clarithromycine ou Spiramycine (existent sous forme injectable)

- **Bithérapie non recommandée**

Arguments thérapeutiques

Macrolides

- Azithromycine : molécule de référence car meilleur rapport PK/PD et ayant le plus grand nombre de données cliniques d'efficacité
- Alternatives :
  - Clarithromycine : CMI sur *Legionella* inférieure à l'érythromycine, à la roxithromycine et à la spiramycine.
  - Spiramycine (PO ou IV) : moins d'interactions médicamenteuses que les autres macrolides.
  - Roxithromycine
  - Erythromycine : mauvais rapport bénéfice-sécurité d'emploi

Rifampicine

- Pas d’indication dans la légionellose
- Efficacité supérieure jamais démontrée en association dans les légionelloses graves
- Interactions médicamenteuses nombreuses
- Exceptionnellement envisageable en association à la doxycycline et en cas de contre indication aux macrolides et aux fluoroquinolones

Doxycycline

- Efficacité non démontrée
- Exceptionnellement envisageable en association avec la rifampicine et en cas de contre indication aux macrolides et aux fluoroquinolones ce qui reste exceptionnel

Posologies

Antibiotique	Hors soins critiques (voie orale)	En soins critiques (voie IV)
Lévofloxacine	500 mg/j	500 mg à 1000 mg/j
Azithromycine	500 mg/j	Non (IV non disponible)
Clarithromycine	500 mg x 2/j	500 mg x 2/j
Spiramycine	1,5 MUI à 3 MUI x 3/j	3 MUI x 3/j
Roxithromycine	150 mg x2/j	Non
Doxycycline	100 mg X2/j	Non
Rifampicine	10 mg/kg/j	10 mg/kg/j

Durée de traitement

- Durée optimale de l’antibiothérapie non démontrée : aucune étude randomisée n'a évalué la durée de traitement
- La durée du traitement est basée sur des méta analyses ou des études sur les pneumonies aiguës communautaires
- La durée du traitement antibiotique spécifiquement chez les patients atteints de légionellose est fonction de:

  - l'antibiotique utilisé,
  - la gravité de la maladie
  - la réponse au traitement
  - le terrain

Durées suggérées de traitement

- **Forme non grave, immunocompétent**
  - **3 jours si Azithromycine**
  - **7 jours si Clarithromycine, Roxithromycine, Spiramycine ou Lévofloxacine (si CI aux macrolides)**

- **Patients immunodéprimés non graves**
  - **5 jours si Azithromycine,**
  - **10 jours si Lévofloxacine ou Clarithromycine**

- **Pneumonie grave***
  - **7 jours : Spiramycine IV ou Clarithromycine IV ou Lévofloxacine IV**

- **Patients immunodéprimés graves***
  - **10 jours : Lévofloxacine IV ou Clarithromycine IV**

**Relais oral dès stabilité clinique*

Prévention

- Prophylaxie antibiotique
  - **non recommandée** même si présence de *Legionella* dans l'eau.
  - Efficacité non démontrée
  - Envisageable dans des cas très particuliers en mesurant le rapport bénéfice/risque de l'antibiotique utilisé si :

    épidémie nosocomiale chez des patients à très haut risque

    et exposition avérée

    et seulement après décision collégiale (CLIN, comité anti-infectieux)

    et en accompagnement d'efforts rigoureux de désinfection et de contrôle de l'environnement.

- Prévention prioritaire = mesures environnementales + maintenance des installations + gestion du risque aéroporté